

Aquablation (Phẫu thuật tuyến tiền liệt bằng tia nước)

Thông tin cho bệnh nhân · Điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng tia nước áp lực, không dùng nhiệt, có hướng dẫn hình ảnh

WARWIKI

Aquablation (cắt đốt bằng tia nước) là phương pháp phẫu thuật mới hơn điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH), sử dụng **tia nước áp lực cao, không dùng nhiệt**, được hướng dẫn bằng siêu âm và đưa qua niệu đạo để loại bỏ chính xác mô gây tắc nghẽn dòng nước tiểu. Phương pháp này giúp giải phóng tắc nghẽn trong khi bảo tồn chức năng tình dục tốt hơn — trong các nghiên cứu, nó gây **xuất tinh ngược dòng ít hơn** so với TURP.

Về thủ thuật này

Dùng ống nội soi kết hợp hình ảnh **siêu âm** thời gian thực của tuyến tiền liệt, bác sĩ phẫu thuật xác định chính xác phần mô cần loại bỏ. Sau đó, **tia nước được điều khiển bằng robot** loại bỏ mô đó một cách chính xác mà không dùng nhiệt. Một bước đốt điện ngắn kiểm soát chảy máu, và ống thông được đặt sau đó.

Tại sao chọn Aquablation

- **Hướng dẫn hình ảnh và chính xác**, hiệu quả trên nhiều kích thước tuyến tiền liệt (kể cả tuyến lớn)
- Cải thiện lưu lượng nước tiểu **tương đương TURP**
- Thiết kế nhằm **bảo tồn chức năng xuất tinh** tốt hơn TURP

Đây là lựa chọn tương đối mới, nên dữ liệu dài hạn vẫn đang được tích lũy.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Aquablation

Loại bỏ mô tuyến tiền liệt bằng tia nước áp lực để điều trị BPH.

BPH

Tăng sản lành tính (không phải ung thư) tuyến tiền liệt.

Không dùng nhiệt

Dùng áp lực nước, không dùng nhiệt, để loại bỏ mô.

Hướng dẫn siêu âm

Hình ảnh trực tiếp giúp bác sĩ xác định chính xác vùng cần điều trị.

Xuất tinh ngược dòng

Cực khoái khô — ít gặp hơn sau Aquablation so với TURP.

Ống thông

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi bàng quang trong một đến hai ngày sau thủ thuật.

KHÁC GÌ SO VỚI TURP? Aquablation loại bỏ mô tuyến tiền liệt bằng **tia nước áp lực chính xác, không dùng nhiệt, có hướng dẫn siêu âm** thay vì vòng điện. Kết quả cải thiện lưu lượng nước tiểu tương đương TURP, nhưng **bảo tồn chức năng xuất tinh** tốt hơn. Hạn chế là phương pháp còn mới, dữ liệu dài hạn chưa đầy đủ, và cần bước đốt điện ngăn để kiểm soát chảy máu.

Cách chuẩn bị

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống** — tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc (ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng trước.
- Sắp xếp người đưa đón; chuẩn bị cho thời gian đặt ống thông ngắn.

Quá trình & Sau khi thủ thuật

- 1 Bạn được gây mê hoặc gây tê; kháng sinh được dùng trước.
- 2 Siêu âm xác định tuyến tiền liệt và bác sĩ lên kế hoạch vùng cần điều trị.
- 3 Tia nước loại bỏ mô; một bước ngăn kiểm soát chảy máu.
- 4 Ống thông được đặt, thường rút sau khoảng **1–2 ngày**; thường nằm viện một đêm.

Dự kiến **nước tiểu có màu hồng** và có cảm giác buốt/tiểu gấp trong vài tuần; uống nhiều nước, tránh rặn mạnh và mang vật nặng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không tiểu được** sau khi rút ống thông
- **Chảy máu nhiều hoặc có cục máu đông** gây tắc nghẽn
- Sốt hoặc ớn lạnh
- Chảy máu ngày càng nhiều hơn thay vì giảm đi

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Aquablation loại bỏ mô tuyến tiền liệt gây tắc nghẽn bằng tia nước áp lực chính xác, không dùng nhiệt, có hướng dẫn siêu âm qua niệu đạo.
2. Kết quả lưu lượng nước tiểu tương đương TURP, với khả năng **bảo tồn chức năng xuất tinh** cao hơn; phương pháp còn mới nên dữ liệu dài hạn vẫn đang tích lũy.
3. Thời gian đặt ống thông ngắn. Gọi ngay nếu không tiểu được, chảy máu nhiều, hoặc sốt.